

Cztery kwadranty — *wszystkie równie ważne*

Bilans 2×2: korzyści AN, koszty AN, korzyści zdrowienia, koszty zdrowienia. Wszystkie cztery muszą być uczciwie wypełnione. Bez perswazji.

CZAS: 45 min ćwiczenia + omówienie **REALIZACJA:** sesja 2-4, powtarzaj co 3-6 mies.

ŹRÓDŁO: Janis & Mann (1977, *Decision Making*); Miller & Rollnick (2013, MI); Treasure & Schmidt (MANTRA)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **narzędzie 2×2**: czterokwadrantowy bilans ambiwalencji. W sekcji 02 — **twój własny bilans** z miejscem na wpis. Sekcja 03 — **refleksja po wypełnieniu**: co zauważasz, co cię zaskoczyło, co teraz wybierasz.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bilans decyzyjny (Janis & Mann, 1977) zaadaptowany dla AN — narzędzie strukturyzujące pracę z ambiwalencją. Cztery kwadranty: *korzyści z utrzymania AN, koszty utrzymania AN, korzyści z wyzdrowienia, koszty wyzdrowienia*. **Wszystkie cztery są realne** — to nie ćwiczenie „do której strony przeważyć”, lecz wizualizacja struktury konfliktu. Terapeuta *nie* staje po stronie „wyzdrowienia” — eksploruje wszystkie cztery z pacjentem. To MI w działaniu.

01 Narzędzie 2×2 — wszystkie kwadranty równie ważne

A · KORZYŚCI Z AN

Co AN ci daje, przed czym chroni. Kontrola, tożsamość („specjalność”), bezpieczeństwo, regulacja emocji, rytuał, sukces w wąsko zdefiniowanym obszarze. *Bez perswazji — uczciwie.*

B · KOSZTY AN

Co AN ci zabiera, jak cię ogranicza. Zdrowie, relacje, sens, energia, miesiączka, perspektywy, samotność, izolacja, koszty finansowe terapii.

C · KORZYŚCI ZDROWIENIA

Co zyskam, jakie możliwości się otworzą. Życie, energia, relacje, swoboda, kariera, dziecko (jeśli chcę), pasje, jasność umysłu, wolność od myśli o jedzeniu.

D · KOSZTY / OBAWY ZDROWIENIA

Co stracę, czego się boję. Utrata kontroli, lęk przed wagą, „kim będę bez AN?”, oczekiwania innych, niepewność tożsamości, strach przed nawrotem. *Bez wstydu.*

A • KORZYŚCI Z AN

— co AN ci daje? Przed czym chroni? Jakie potrzeby zaspokaja?
Pisz uczciwie, bez „poprawnych” odpowiedzi

B • KOSZTY AN

— co AN ci zabiera? Jak cię ogranicza? Zdrowie, relacje, sens,
energia, czas, koszty

C • KORZYŚCI ZDROWIENIA

— co zyskam? Jakie możliwości się otworzą? Co znów stanie się
dostępne?

D • KOSZTY/OBAWY ZDROWIENIA

— co stracę? Czego się boję? Nazwanie obaw nie znaczy, że
masz im ulec — znaczy, że są widoczne

CO CIĘ ZASKOCZYŁO

— który kwadrant okazał się najpełniejszy / najtrudniejszy do
wypełnienia?

JAKI KIERUNEK WYBIERAM NA TERAZ

— pełne zdrowienie / częściowa zmiana / utrzymanie status quo;
każdy wybór jest informacją, nie ostateczną decyzją

Klucz: bilans decyzyjny *nie* jest narzędziem perswazji — jest narzędziem *obserwacji własnego konfliktu*. Klinicysta, który próbuje „pomóc” pacjentowi „znaleźć więcej” w kolumnie kosztów AN lub korzyści zdrowienia, łamie zasadę Motivational Interviewing — zjawisko *reactance* (Brehm, 1966) sprawia, że pacjent *jeszcze bardziej* broni AN. Skuteczne podejście: *walidacja* wszystkich czterech kwadrantów. Korzyści AN są *prawdziwe* — to powody, dla których pacjent ją wybiera. Obawy zdrowienia są *prawdziwe* — to nie „opór”, to realne obawy. Powtarzaj bilans co 3–6 mies. — obserwuj jak się zmienia. Korzyści zdrowienia zwykle rosną, obawy maleją, koszty AN stają się bardziej widoczne. To narzędzie obserwacji procesu motywacji, nie tylko zachowania.

⚠️ Jeśli kwadranty nie dają się wypełnić uczciwie (np. „nie wiem, co AN mi daje”) — to często sygnał, że ego-syntoniczność AN jest bardzo silna lub że potrzebny jest dłuższy czas eksploracji. Nie wymuszaj wypełnienia. Sesja eksploracji funkcji AN może poprzedzać bilans.